

A background image showing a close-up of grass blades covered in a fine layer of white frost or dew. The scene is misty or foggy, with a soft, diffused light source in the upper right corner creating a bokeh effect with out-of-focus light spots. The overall color palette is cool, dominated by blues, greys, and whites, with some green from the grass blades.

Psoriazis, Lichen plan, Ulcer cronic de gamba

Sef lucrari Dr. Candrea Elisabeta



Psoriazis

Psoriazis- definitie

- = patologie cronică, inflamatorie, non-infecțioasă a pielii
- Se caracterizează printr-o **proliferare keratinocitară excesivă** precum și infiltrare cu celule inflamatorii
- Pacienții afectați de psoriazis prezintă o predispoziție genetică, boala fiind declanșată în urma apariției unui factor trigger precum infecție, stres, medicamente, etc



Incidenta si prevalenta

- F~ B
- Prevalenta variaza in functie de factorii demografici, etnici, de mediu (zone insorite)
- 2% raportat in Europa, SUA
- Orice varsta
- Incidenta cea mai crescuta: intre 20-40 ani

Factori trigger

externi

- Diversi: arsuri solare, exantem viral;
- Fenomenul Koebner= aparitia de noi leziuni de psoriazis in urma unei injurii cutanate



sistemici

- **Infectii:** infectii bacteriene, exp streptococ, HIV
- Stres:
(Nivel ↑cortizol- agravare)
- **Medicamente:**
 - Litiu, IFN, beta-blocante, antimalarice;
 - Scadere rapida a CS sistemici- agravare
- Factori endocrini:
 - Hipocalcemia, sarcina (50% imbunatatire)
- Alcool, fumat (?)

Forme clinice

PSORIAZIS VULGAR

PSORIAZIS GUTAT

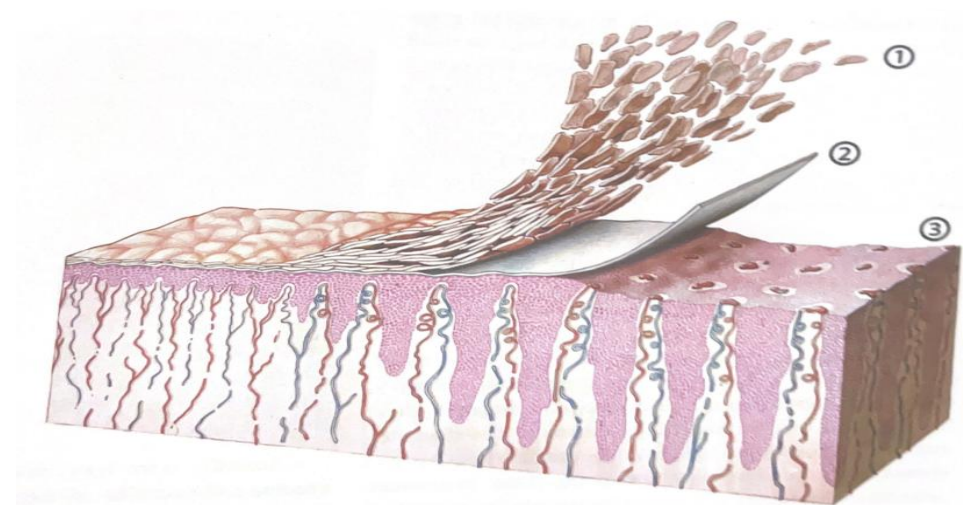
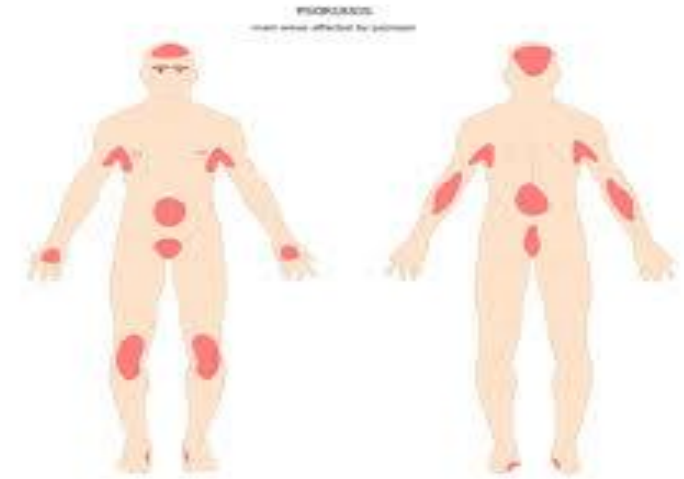
PSORIAZIS PUSTULOS

PSORIAZIS ERITRODERMIC

PSORIAZIS ARTROPATIC

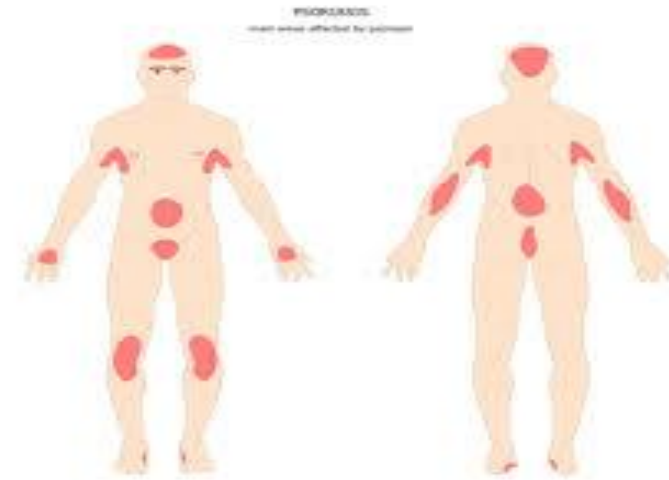
Psoriazis vulgar

- Placi eritemato-scuamoase, bine delimitate, cu scuama **groasa, multistratificata**
- Leziuni circulare, ovale sau policiclice, bine delimitate, cu distributie frecvent simetrica;
- Suprafata cutanata afectata poate fi variabila.



Psoriazis vulgar

- Zone frecvent afectate: scalp, coate, genunchi, zona lombo-sacrata dar pot fi afectate si alte zone cutanate;
- Fenomenul Koebner



Localizari speciale

Psoriazisul scalpului

- Una din zonele frecvent afectate (50-80%)
- Uneori leziunile avanseaza catre fata, exp. retroauricular sau cervical posterior
- Poate fi singura zona afectata
- Prurit frecvent → impetiginizare secundara
- Fara alopecie
- Dg dif: dermatita seboreica, tinea capitis, dermatomiozita



Localizari speciale/ variante topografice

Psoriazis palmo-plantar

- Semiologia este atipica, leziuni flu delimitate, **eritemato-scuamoase** sau intens **keratozice**, fisurate
- Se pot extinde catre incheieturi si glezne
- Dg dif: eczeme de contact, dermatofitoze, limfom cutanat cel T, etc



Localizari speciale/ variante topografice



Psoriazis unghial

- De multe ori precede afectarea articulara;
- Depresiuni punctiforme, striuri transversale
- Onicodistrofie majora
- Hiperkeratoza subunghiala, ingrosare unghiala

Forme clinice

PSORIAZIS VULGAR

PSORIAZIS GUTAT

PSORIAZIS PUSTULOS

PSORIAZIS ERITRODERMIC

PSORIAZIS ARTROPATIC

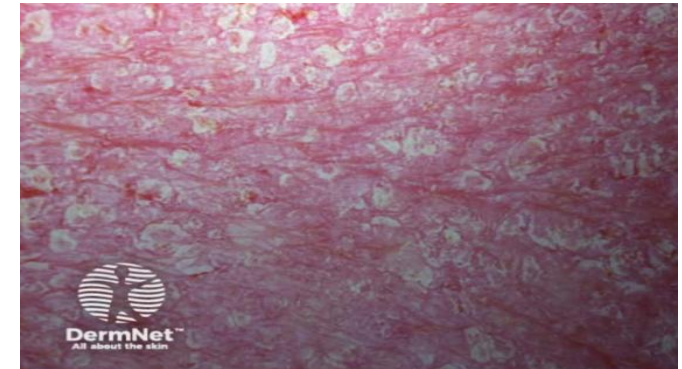
Psoriazis gutat

- Apare mai frecvent la copii si adolescenti;
- Frecvent dupa o infectie streptococica (faringita streptococica) sau infectie virala
- Leziuni eritemato-scuamoase cu **diametru <1cm**
- Uneori- rezolutie spontana (3-4l)
- 1/3 din pacienti dezvoltă psoriazis vulgar



Psoriazis eritrodermic

- Eritem si scuame **generalizate**
- Debut: acut sau cronic
- Pacientii sunt la risc de: pneumopatie infectioasa, septicemie, tulburari de termoreglare si hidroelectrolitice, anemie, hipoalbuminemie, insuficienta cardiaca



Psoriazis pustulos

- **Pustule** la nivel acral care afecteaza aparatul unghial (1 deget)

Pustuloza palmo-plantara

- Pustule vizibile palmare, plantare, durata > 3 luni
- Cu sau fara context de psoriazis pustulod generalizat



Psoriazis pustulos generalizat

- Pustule sterile diseminate la nivelul toracelui si membrelor (pe zone non-acrale)
- Cu sau fara elemente caracteristice pentru psoriazis vulgar
- Leziunile pot fi persistente sau pot exista recaderi



Artrita psoriazica

- **Artrita inflamatorie seronegativa** pt FR

Leziunile cutanate apar	% pacienti
Inainte de artrita	80%
Simultan	15%
Dupa artita	5%

Forme:

- Poliarticular simetric
- Oligoarticular asimetric
- Interfalangian distal
- Axial
- Mutilant



Clinic:

- **Redoare matinala**
- Modificari **radiologice**

Manifestari extraarticulare:

- Afectare unghiala
- **Dactilita-** deget in carnacier
- **Entezite**, Edeme perferice
- Afectare oculara

Tratament

Terapii topice

- De prima intentie cand afectarea cutanata este limitata;
- Adjuvant in formele severe;

Terapii sistemice

- Fototerapia
- Tratamente sistemice clasice
- Terapii biologice

Terapii topice

- **Keratolitice**: acid salicilic 3-5% adulti
- **Dermocorticoizi**: clasa 3 sau 4
 - Apare in timp tahifilaxia
 - Asociere cu derivati vit D
- **Derivati de vit D**: calcipotriol,
 - Profil de siguranta bun pe termen lung
 - Efect terapeutic usor intarziat in comparatie cu dermocorticoizii
- Altele: emoliente, bai sarate, etc

fototerapia

PUVA (315-400nm)

- = substanta fotosensibilizanta+ **UVA**
- 3 sed/sapt → rezolutie in 80-90% pacienti;
- Dezavantaje: intoleranta digestiva, imbatranire cutanata, risc de tu maligne cutanate → oprire la doze de 1200-1500J/cm² UVA

UVB-NB (311-313nm)

- **UVB-NB** (narrow-band)
- Eficienta similara/ usor mai scazuta;
- Ameliorare semnificativa
- Efecte mai putin durabile dar si efecte adverse mai scazute

Tratamente sistemice

Tratamente sistemice conventionale

- Acitretin
- Metotrexat
- Ciclosporina
- Apremilast



Terapii biologice

- inhibitori **TNF-alfa** : Se fixeaza pe TNF-alfa solubil& membranar;
- Inhibitori de **Interleukina-23**: Ustekinumab
- **Inhibitori de IL- 17**: Sekukinumab, Ixekizumab, Bimekizumab

Lichen plan

- Afectiune cutanata cronica, pruriginoasa
- Poate afecta **tegumentul**, **mucoasele**, părul (alopecie cicatriciala) și unghiile
- F>B, 40 ani
- Etiologie neclara (reactie imuna mediata de limfocitele T impotriva keratinocitelor bazale)
- Forme clinice multiple



Lichen plan

ASPECT CLINIC

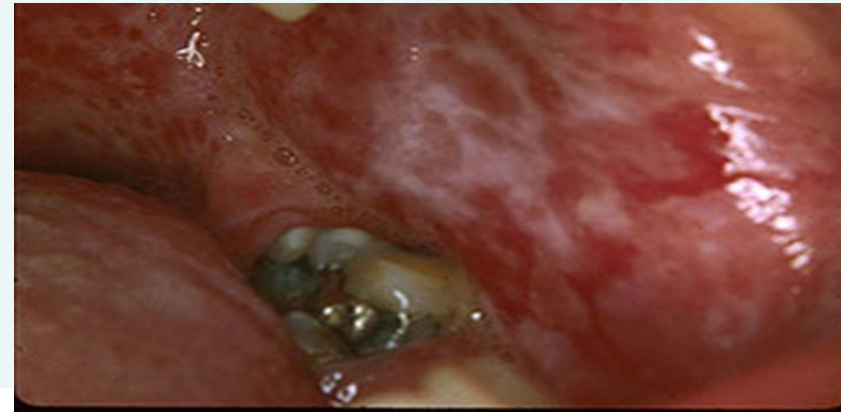
- Leziunea tipica de la nivelul tegumentului:
- **papula rosie-violacee, plana**, lucioasa, forma **poligonala**, **pruriginoasa**, striuri albe pe suprafata, fenomen Koebner



Lichen plan

ASPECT CLINIC

- Mucoasa bucala:
- Retea alba, eroziuni, ulceratii dureroase, placi eritematoase
- Risc de transformare in CSC bucal: 1,1% (mai mare la fumatori, alcoolism, infectie VHC)





Lichen plan

- Tratament:
 - dermocorticoizi locali/ sistemici
 - inhibitori de calcineurina,
 - retinoizi,
 - Fototerapie: PUVA/ UVA, UVB-NB
 - imunosupresoare



A background image of grass covered in a thick layer of white frost or snow. The grass blades are thin and green, contrasting with the white covering. The scene is misty or foggy, with soft, out-of-focus light in the background, creating a serene and cold atmosphere. The text is overlaid on the left side of the image.

Ulcere cronice de gamba

Ulceratia Cronica

Ulcerale cutanate reprezinta o pierdere de substanta de la nivelul tegumentului.

Afectare a epidermului si dermului

Majoritatea sunt situate la nivelul membrelor inferioare

Insuficienta
venoasa cronica

Boala arteriala
periferica

Neuropatie
periferica



Ulcerele venoase cronice

Insuficienta venoasa cronica

Afectiune frecventa

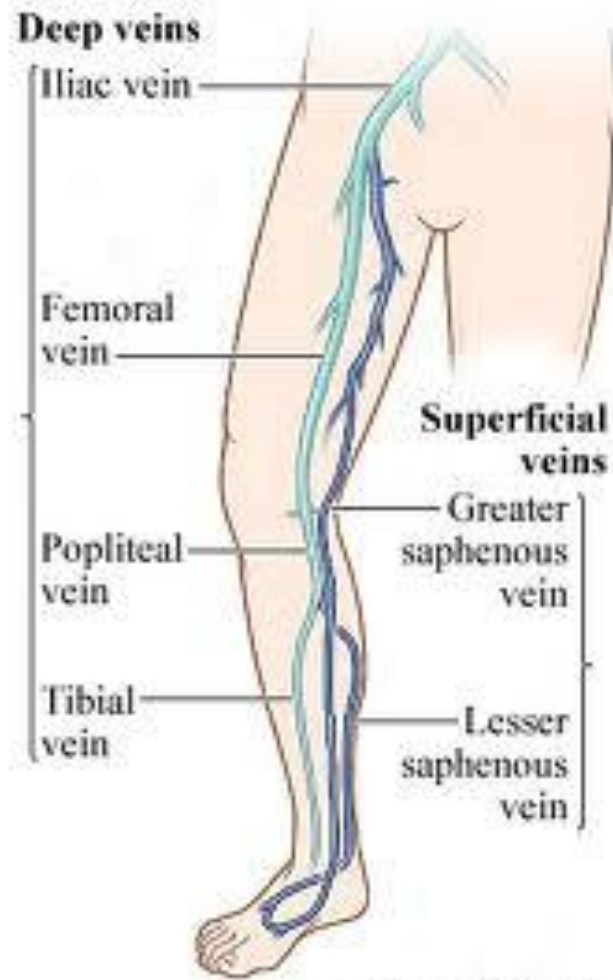
Incidenta creste o data cu varsta

Prevalenta: <1-17% barbati; <1-40% femei

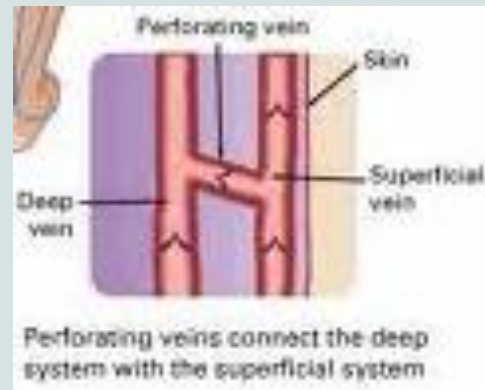
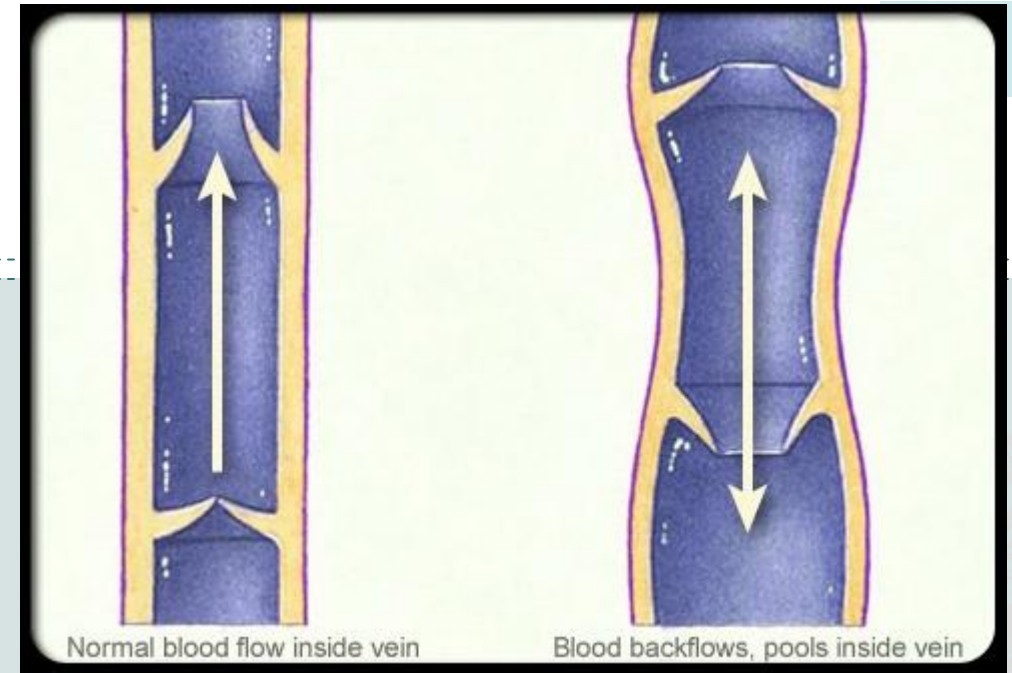
Factorii de risc:

- AHC
- Varsta
- Sex feminin
- Obezitatea
- Sarcini
- Ortostatism prelungit

Ulcerul venos



© Healthwise, Incorporated



CEAP Classification System and Reporting Standard Revision 2020

C (Clinical Manifestations), **E** (Etiology), **A** (Anatomic Distribution), **P** (Pathophysiology)

C0	No visible or palpable signs of venous disease
C1	Telangiectasias or reticular veins
C2	Varicose veins
C2r	Recurrent varicose veins
C3	Edema
C4	Changes in skin and subcutaneous tissue secondary to chronic venous disease
C4a	Pigmentation or eczema
C4b	Lipodermatosclerosis or atrophie blanche
C4c	Corona phlebectatica
C5	Healed
C6	Active venous ulcer
C6r	Recurrent active venous ulcer

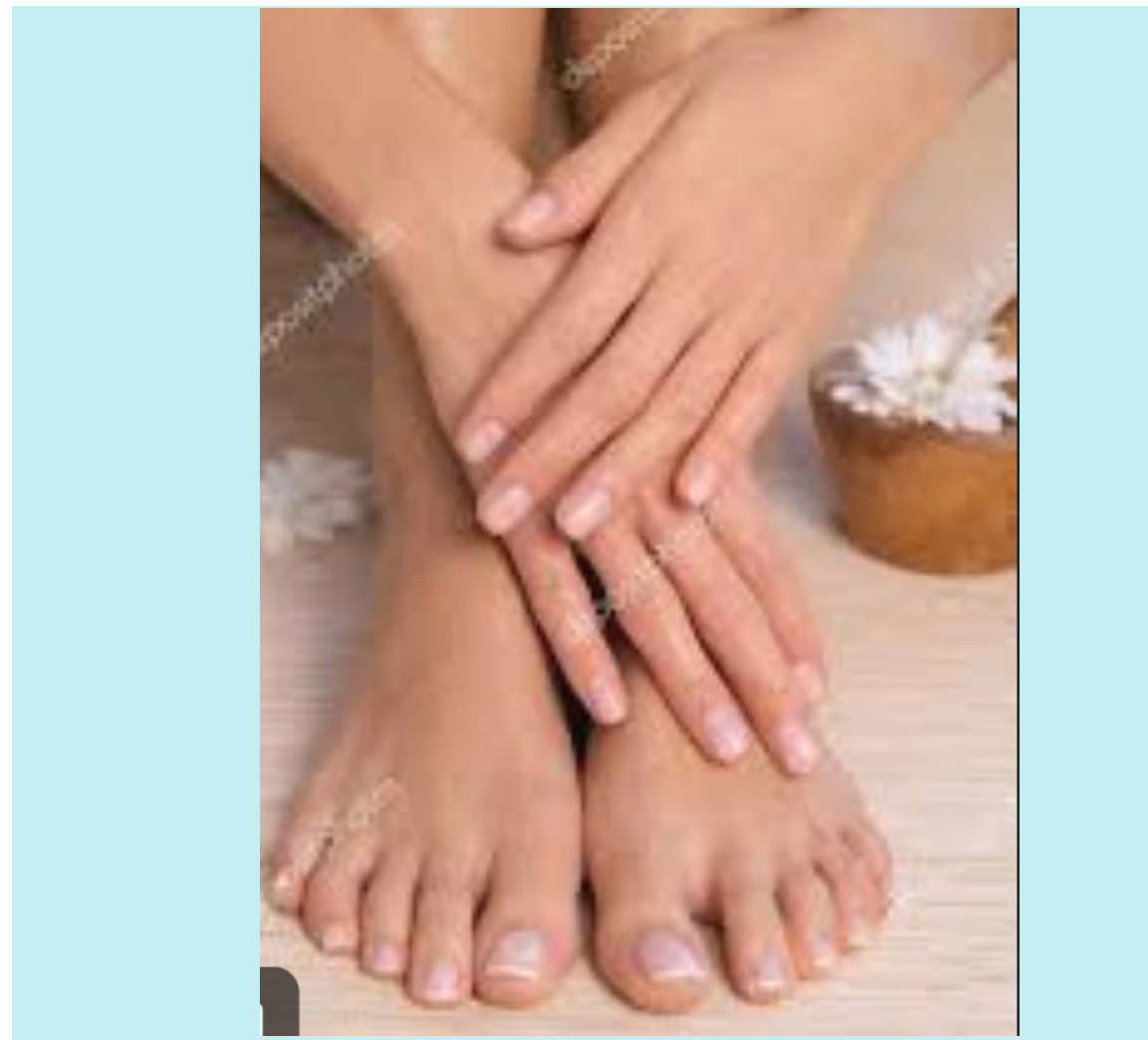
Aspecte clinice din insuficienta venoasa cronica





C0- simptome

Senzație de greutate în gambe
Senzație de umflare a gambelor
Durere
Parestezii



- C1



Telangiectazii
Vene reticulare





Stadiu C2

Vene varicoase



Stadiu C3

Edeme



Vesperal

Ortostatism prelungit

Stadiu C4

Eczema de staza



Dermatita pigmentară

Stadiu C4



hemosiderină

Stadiu C4

Dermatoscleroza



Proces dermo-hypodermic scleros (inflamatie non-infectioasa a dermului si hipodermului)
Ingrosare dureroasa a pielii
Eritem cu aspect de pseudoerizipel
Scleroza induce o constrictie locala (pahar de sampanie inversat)

Stadiu C4

Coroana flebectatica



Stadiu C5

Ulcer epitelizat



Stadiu C6

Ulcer venos



1/3 inf gambă - perimaleolar

**Aspect: dimensiuni
profundzime
suprafață?
marginii**

teg periulceros

Durere—nu e proporțională cu suprafața

Prurit periulceros



Diagnostic diferencial

- Ulcere arteriale
- Ulcere neuropate (neuropatie diabetica)
- Vasculita
- Ulcere posttraumatice

Ulcere arteriale

Manifestari clinice

- Majoritatea: asimptomatici

- Claudicatie intermitenta

- Durere la repaus
- Ameliorarea durerii la coborarea picioarelor



Ulcere arteriale

Manifestari clinice

- Pulsuri scazute/ absente, picioare reci
- Lipsa semnelor de insuficienta venoasa cronica
- Indice glezna- brat= $\frac{\text{Presiune sistolica glezna}}{\text{presiune sistolica brat}}$
<0.9 este sugestiva pentru boala arteriala periferica

Evaluare Doppler



ULCER DIABETIC/ NEUROPAT

Manifestari clinice

- Localizare : zone de presiune pe suprafete osoase (metatars, calcai, haluce)
- Diminuarea sensibilitatii locale
- Deformari plantare frecvente



Diagnostic diferential ale celor 3 ulcere principale de la nivelul gambei

	Leziune	Localizare	Tegument perilezional	Date generale
Venos	Neregulata Margini abrupte/panta Baza necrotica Fibrina	Maleolara/ supramaleolara medial	Lipodermatoscleroza Dermatita de staza Atrofie alba Pigmentare Limfedem	Varice Durere accentuate in pozitie decliva
Arterial	Aspect stantat Baza necrotica	Puncte de presiune distala (degete, pretibial, suprmaleolar)	Atrofic, lucios	Puls neperceptibil/slab
Neuropatic	Aspect stantat	Puncte de presiune Plantar	Calus present inainte de aparitia ulcerului; hiperkeratoza periulceroasa	Paloare la ridicarea piciorului si accentuarea durerii Neuropatie periferica



Principii terapeutice ale ulcerelor de gamba

Tratamentul ulcerului venos

IVC

Ulcer venos

Manifestari
asociate

Epitelizarea unei leziuni ulcerative

Perfuzie
adecvata

Status nutritional &
imun adecvat

Evitarea
traumatismului
local

Ulcerul venos- Tratament

- **Măsuri generale** – evitarea ortostatismului prelungit, activități fizice care favorizează întoarcerea venoasă (mers pe jos, înot, mers pe bicicletă), clinostatism cu picioarele ridicate (45°), evitarea purtării de articole de îmbrăcăminte care strâng, evitarea temperaturilor crescute
- **Terapia compresivă** – esențială – ciorapi elastici sau bandaje compresive – atenție la boală arterială periferică asociată!!
- **Sistemic** – flebotonice, flavonoizi exp diosmina (Detralex)
- Scleroterapie/ tratament laser endovascular/ transcutanat
- Tratament **chirurgical** al varicelor

Tratament topic

Curatarea plagii

- Apa
- Solutie de clorhexidina
- Solutie de Polihexanida

Debridare

- Indepartarea tesutului necrotic, non-viabil (depozite de fibrina, necroza)
- Mecanic: curetaj
- Enzimatic: enzime proteolitice (colagenaze)
- Pansamente hidrocoloide

Pansamente

- Crema cu **Sulfadiazina de Argint**
- membrana poliuretana, pansament hidrocoloid, alginat, pansamente impregnate cu argint



✓ **Pansament cu Alginat**



✓ **Pansament impregnat
cu argint**

Grefe cutanate







Va multumesc!

